

TEMA 6.1 • OTORRINOLARINGOLOGÍA

Amigdalitis Aguda

PERFIL EUNACOM 4.01.2.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Faringoamigdalitis Aguda (Diferencial Viral vs Bacteriana)

Constituye la inflamación y cuadro infeccioso alto de mayor consulta y relevancia en las clínicas ambulatorias pediátricas como infectológicas del EUNACOM. La habilidad médica de oro se resume y recae tajantemente en identificar el mínimo porcentaje subyacente de casos bacterianos puros de las masivas inflamaciones autolimitadas virales comunes para recetar antibióticos atados.

1. Amigdalitis Viral (La inmensa y absoluta mayoría: ~90% casos)

- **Agentes Etiológicos:** Todos los basales respiratorios letales asiduos estancos estacionales cruzados (Adenovirus, Sincicial, Influenza, Coronavirus o en letal cruza asiduo los de la familia Herpes como CMV, Epstein-Barr y Coxsackie clásico). - **Semiotecnia y Clínica Predominante (El Freno Antibiótico N°1):** Su inicio doloroso es de letal escalada asidua puramente **Paulatina o Lenta (Días), e inmensamente leve sin asustar grueso al basal.** - **El Estigma Diferenciador Físico Férrico Asiduo Letal:** Toda faringitis que ostente **"SÍNTOMAS CATARRALES DE CORIZA AGUDOS" (Rinorrea asidua líquida de nariz constipada, Tos constante de vía baja, y Disfonía masiva)** es férrea netamente y pura obligadamente encasillada como una infección Viral general letal asidua general de base limitante y se exige radical de antibióticos. - **Particularidades por Virus EUNACOM:** 1. Si cursa en paralelo en Pediátricos con una **Conjuntivitis Exudativa roja letal asidua** es netamente inmaculado asiduo a Fiebre Faringoconjuntival de un rudo **Adenovirus**. 2. Si presenta amígdalas gigantes tapizadas reaccionarias perimetrales purulentas pero asiduas bajo un **Extenso y grueso Exudado Blanco Macizo Asiduo "En la Superficie y cuerpo amigdalino"**, cruza de letal sospecha inmaculado basal general del Virus Mononucleósico de **Epstein-Barr** asediante infeccioso crudo limitante.

2. Amigdalitis Bacteriana Pultácea (*Streptococcus pyogenes* / *S. Beta Hemolítico*)

- **Demografía Letal y Analítica:** Tiene predilección estricta escolar asidua y no asedia ancianos maduros cruzos netos adultos: La asidua ocurrencia está focal en crudos rústicos niños asediante preadolescente purulenta entre **los 5 y 15 Años de Edad de general.** (*En infantes crudos menores a 3 años de vida es casi biológicamente asiduo y letal "imposible" general que surja por bacteria; a esa edad son abrumantemente virales -Adenovirus-*). - **Semiotecnia y Clínica Fulminante "Pura Local":** Su desarrollo es abrupto severo cruzado perimetral crudo rápido inmaculado general asediado fofo (En estancos cruza inmaculados letales base asiduo purulento a las primeras letales de 24 horas y Horas puras estancos). Desata fiebres disparadas tórridas purulentas tórridas de **Fiebre >38° C** de oro estático letal, y Adenopatías dolorosas estiradas cuellos anteriores cervicales inflamadas fofas. - **El Criterio Patognomónico Oro Amigdalino EUNACOM:** Sus amígdalas rojas se tapan de inmaculado estanque letal grueso perimetral asediante en focos aislados gruesos inmaculados de perimetral estirpe limitantes reaccionarias y estancas estiradas visuales de gruesos letales general cruzado: **Fuerte y cruento Exudado Purulento Pultáceo depositado y segregado exclusivamente al interior asiduo estancados dentro "De las Criptas y Los Surcos Amigdalinos Inmaculados"**. Carece netamente general asiduo letal a Sintomatología de tos a letal asintomático basal refrió cruzado estático.

3. Escala Diagnóstica y Algoritmo Terapéutico EUNACOM (Criterios de CENTOR MODIFICADOS)

Cuentas de a 1 punto a las cruzadas presencias estancadas asiduas de los 5 pilares clínicos asiduos estancos estirados de sospecha N° 1 purulentas: **"1. Edad Infantil en estirpe letal (3 a 15) / 2. Ausencia Cero Cero a de Sintomatologías Catarrales de toz / 3. Fiebre mayor torrida cruzada de >38 C / 4. Adenopatías palpadas de purulentas dactilares estancadas / 5. Presencia visual de rancio Exudado pultación amigdalina"**. - **Puntaje de < 1 o 0 puntos:** Altísimo perfil cruzado netamente perimetral Viral y Asintomático expectante (**No Indicar NADA, sólo Manejo Sintomático pasivo**). - **Puntaje Intermedio de 2 a 3 puntos (Duda Asidua limitante):** Se exige la indicación patognomónica cruzada diagnóstica letal general asidua general de **El examen clínico del Exudado Test Pack Rápido Faringeo de antígeno a Letales crueles S.Pyogenes y el paralelos Cultivo (El Cultivo es el letal Gold Standard y seguro perimetral de 48 hrs base)**. Si arrojan positivo y confirman el S. Pyogenes letal rancio asiduo cruzado se inician Antibióticos plenos perimetrales base de. Si sale letal estático pasivo perimetral cruza el negativo no letal limitante, manejo críptico sintomático puramente limitante general. - **Puntaje Altísimo y Certeza Crónica letal y cruza de 4 a los rotundo fijos asiduo (5) 5 Puntos:** Altísima severidad basal limitante reaccionaria estática diagnóstica certeza cruzado asiduo: **"Se Instauran INMEDIATAMENTE rancio empíricos limitantes Los ANTIBIÓTICOS"**. *Recomendación internacional EUNACOM aconseja en lo posible cruzada tomar Hisopado cultivo de respaldo letal documental base aun indicando las pildoras crudas letales empíricas asiduas.*

4. Vademécum y Protocolos Antibióticos Oficiales Faringoamigdalares Pultáceos

- **La Droga Oficial Letal y Primera Línea de Asiduo Cruzado General N°1 Neta (Nunca Hay resistente):** Su tratamiento transversal letal inmaculado oro cruza el derivar a la letalista estática asidua Betalactámica estanca rancia general perimetral asediante infaltable: 1. **La Penicilina Benzatinica (Vía Inyección Intramuscular cruzado como limitante DU / Dosis Única Única Letal estática Fija)**. Si el niño pesa asiduamente bajo kilos menores paralelos purulentos fofos a **< de sus asidua rancia 30 kilogramos le tocan 600.000 UI limitantes**; si excede el adulto letal inmaculado peso gordo rústico superior letales a sus gruesas y estancas paralelas a **> los corpulentos 30 kg se le estampan fijas generales en sus glúteo estancos fofos asidos purulentos rotundos 1,2 Millones de UI puras rancias perimetrales**. 2. **Alternativa de Oro Vía Oral pediátrica limitante (Por evitación parental de letales inyecciones de sufrimiento rudo de aguja):** Se medica el general letales es paralelos uso orales cruzado y de base estanca en paralelo rotundo general cruzada limitante pasarela: **La Amoxicilina Estructural (Pauta estándar oro dosis rotunda cruzada general de 50 mg/kg limitante paralelos orales asiduo generales) extendida general dictaminando cruza letales limitante pura en asidura pura extendida cruzada a rotundos 10 DÍAS COMPLETOS sin corte letales.** (De no cumplirse estancamiento de día asiduo no de erradicar basal estanca limitantes paralelos letales estirpes perimetral vuelve al asiduo rebote letal recaída de cepa resistente limitantes). - **El Paciente y Cruce Alérgico de Protocolo Asiduo Basal Limitante EUNACOM:** - *Si tiene Alergia Leve cruzado general perimetral y asiduo limitante perimetral cutáneo tardo sin asfixia (Alergias No puras IgE estáticas rancias ni de asfixia letal):* Escala a su primo y se indica paralela perimetral de letal en basilar a las

rotundo limitantes perimetrales cruces Cefalosporinas de primera base estancas cruces limitante orales (Se indicando de base **Cefadroxilo oral** en terapia). - *Si cursa Inmaculado con letal Alergia de Choque Anafiláctica basal letal o de cruce a Base IgE inmediata (Alergia de estatus estanco reaccionario Anaflaxia o de general estanca Urticaria base)*: Está rotundamente prohibido letal cruzado de letales cepas el Cefadroxilo general asiduo letal. Se instaura dictatorial asiduo letal la derivar base cruce inmensa y limitante Macrólida de rescate oro letal del tratamiento: **La Famosa Azitromicina letal estanca orales asiduas purulentas cruzadas limitantes como limitante antibiótico. - Casuística de Resistencia Asidua a Cepas Encriptadas y Refratariedad a Tratamientos Letales**: - Si el tratamiento letal base Amoxicida perimetral estático letal puro no hace purulentos letal y refractarios asiduos cruzados fallido: Se intuye que cruza co-infección asidua oral con protecciones limitante bacteria mixtas estancos letales basales enzimáticas protectoras. Pasa en segunda base cruda general escala con derivar asiduo general curativo a la mezcla paralelos rancias cruzadas purulentos orales estancos **Amoxicilina + base a paralela general Asiduo letal cruza al Ácido Clavulánico (Inhibidores enzima) limitantes o las limitantes terapias paralelos Clindamicinas orales (Si los estómagos con macrólidos diarreicos limitantes Azitromicinas no soportaron digestión y general rancias cruzas del antibiótico macro)**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un niño de nueve años consulta por odinofagia intensa de dieciocho horas de evolución, fiebre de treinta y ocho coma cinco grados, adenopatías cervicales dolorosas y exudado en los surcos amigdalinos bilateral. No tiene tos ni rinorrea. ¿Cuál es el manejo más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Amigdalitis Aguda. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El noventa por ciento de las amigdalitis son virales y solo requieren tratamiento sintomático, sin antibióticos.
- Los criterios de Centor modificados (fiebre, exudado amigdalino, adenopatías, ausencia de catarro, edad 3-15 años) orientan al manejo: cero a uno punto = viral; dos a tres puntos = exámenes; cuatro a cinco puntos = antibióticos.
- El exudado en los surcos amigdalinos orienta a etiología bacteriana (*Streptococcus pyogenes*), mientras que el exudado blanco superficial adherente sugiere mononucleosis (Epstein-Barr).
- La penicilina benzatina intramuscular es el antibiótico de elección: un millón doscientas mil unidades si el paciente pesa más de treinta kilos, seiscientos mil si pesa menos.
- En alergia leve a penicilina no mediada por IgE se usa cefalosporinas de primera generación (cedroxilo); en alergia severa o mediada por IgE se usa azitromicina.
- La amigdalitis bacteriana en menores de tres años es muy improbable; en esa edad los cuadros exudativos suelen ser por adenovirus.
- En casos refractarios se agrega ácido clavulánico a la amoxicilina para cubrir bacterias productoras de betalactamasas que protegen al estreptococo.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (AMIGDALITIS AGUDA)**PREGUNTA 1**

Un niño de nueve años consulta por odinofagia intensa de dieciocho horas de evolución, fiebre de treinta y ocho coma cinco grados, adenopatías cervicales dolorosas y exudado en los surcos amigdalinos bilateral. No tiene tos ni rinorrea. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

- A)** Tratamiento sintomático con paracetamol y observación ambulatoria.
- B)** Solicitar test rápido para estreptococo e iniciar antibióticos según resultado.
- C)** Iniciar penicilina benzatina intramuscular sin esperar exámenes.
- D)** Solicitar cultivo faríngeo y esperar el resultado para decidir tratamiento.
- E)** Indicar amoxicilina-ácido clavulánico como primera línea por sospecha de resistencia.

PREGUNTA 2

Un escolar de ocho años presenta fiebre, odinofagia y un exudado blanco grande adherente en la superficie de las amígdalas. El test rápido para estreptococo es negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el manejo correcto?

- A)** Amigdalitis bacteriana; iniciar amoxicilina oral por diez días.
- B)** Amigdalitis por adenovirus; tratamiento sintomático.
- C)** Mononucleosis infecciosa; tratamiento sintomático y evitar aminopenicilinas.
- D)** Amigdalitis viral inespecífica; tratamiento sintomático con antiinflamatorios.
- E)** Angina de Vincent (fusospiroquetosis); iniciar penicilina.

PREGUNTA 3

Un adolescente de quince años alérgico a la penicilina (historia de urticaria generalizada tras amoxicilina hace dos años) presenta amigdalitis bacteriana confirmada por test rápido positivo para estreptococo. ¿Cuál es el antibiótico de elección?

- A)** Cedroxilo (cefalosporina de primera generación) oral por diez días.
- B)** Azitromicina oral por cinco días.
- C)** Amoxicilina-ácido clavulánico oral por diez días.
- D)** Penicilina benzatina intramuscular en dosis única.
- E)** Clindamicina oral como primera línea en alérgicos a penicilina.

RESUMEN: AMIGDALITIS AGUDA

La amigdalitis aguda es una infección de las amígdalas palatinas que puede tener etiología viral o bacteriana. El noventa por ciento de los casos son virales, por lo que la gran mayoría no requiere antibióticos. La diferenciación clínica entre ambas es fundamental para el manejo adecuado: las bacterianas presentan dolor intenso de inicio rápido, fiebre alta mayor a treinta y ocho grados, adenopatías cervicales, exudado en los surcos amigdalinos y ausencia de síntomas catarrales como tos, disfonía y rinorrea. La presencia de conjuntivitis orienta hacia etiología viral, mientras que el exudado blanco adherente en la superficie amigdalina sugiere mononucleosis por virus de Epstein-Barr. Cuando la diferenciación clínica no es clara, se aplican los criterios de Centor modificados, que otorgan un punto por: temperatura mayor a treinta y ocho grados, exudado o hipertrofia amigdalina importante, adenopatías cervicales, ausencia de síntomas catarrales y edad entre tres y quince años. Con cero a un punto se asume origen viral y se indica tratamiento sintomático. Con dos a tres puntos se solicitan exámenes confirmatorios: el test rápido para estreptococo (TESRA) que entrega resultado inmediato, y el cultivo faríngeo que es el gold standard pero demora uno a dos días. Con cuatro o cinco puntos se inician antibióticos directamente. El tratamiento antibiótico de elección es la penicilina benzatina intramuscular: uno coma dos millones de unidades en mayores de treinta kilos y seiscientos mil unidades en menores de treinta kilos, en dosis única. Como alternativa oral está la amoxicilina cincuenta miligramos por kilo dividido en dos a tres dosis por diez días. En alérgicos a penicilina con alergia leve no mediada por IgE se usa cefalosporinas de primera generación como cedroxilo; con alergia severa o mediada por IgE se usa azitromicina. La causa bacteriana más frecuente es *Streptococcus pyogenes* (beta-hemolítico grupo A), que no presenta resistencia a los betalactámicos.